

소속, 성명: 평가실 팀부 J 팀장, K 과장

제 목: 암 질환 걱정성 평가 영역 확대

내 용

1. 추진배경

- 2011년부터 시작한 암 걱정성 평가는 주로 수술환자를 중심으로 이루어져 평가되지 않았던 사각지대가 존재하고 진료결과에 비해 과정지표의 비중이 높은 한계가 있었다.
- 또한, 최근 의·약학 발전으로 암 치료법이 다양화되어 수술치료 이후 장기 생존자가 증가함에 따라 그간의 의료 환경변화를 반영한 환자·성과중심 평가로 패러다임 전환이 필요해졌다.

2. 추진내용

- **(평가대상 확대)** 기존 진단·수술 치료 중심에서 수술이 어려운 전이암 환자와 말기암 환자까지 암 진료 전반에 대한 평가로 대상을 확대하여 사각지대를 해소하였다.
- **(평가지표 개선)** 기존 치료과정 중심의 지표에서 수술사망률·재입원을 등 치료성과와 직접 연계되는 결과지표를 신설·확대하였다. 뿐만 아니라, 다학제 진료 활성화 등 환자중심의 지표를 도입하고 호스피스 상담률 등 생애 말 삶의 질 향상을 위한 지표를 신설하였다.
- **(암 평가 확장성 제고)** 다양한 암에 적용 가능한 공통지표를 도입하여 향후 새로운 암 평가 항목 도입을 용이하게 하였다.

※ 5대 암 평가 체계 전환

('20년) 개편 로드맵 수립	('21년) 단계적 개편 실행	('22년) 5대 암 전면 개편 완료
암 평가 개선방안 연구	대장암, 위암, 폐암 2주기 평가 계획 확정 ('22년 7월 평가 도입)	간암, 유방암 2주기 평가 전환 (평가대상기간: '23.1.~12.)

3. 추진성과

- 치료과정 중심에서 암 진료 전반의 성과중심 평가로 전환 및 암 질환의 생애
 쉐 주기 평가체계를 구축함으로써 치료의 실질적 질 향상 기반을 마련하였다.

4. 향후계획

- '24년부터 개편된 5대 암 평가결과 공개 및 기관별 결과통보를 통해 암 질환
 환자 진료의 질 관리가 지속적으로 이어질 계획이다.